

- × 黄色ブドウ球菌の検出が多いのは、本邦では稀だが鑑別として重要な膿胞性線維症である。
- × 病状が進行してから定着しやすい。
- × 増悪時には肺炎球菌やインフルエンザ桿菌が起因菌であることが多い。
- 
- 
- × クラリスロマイシン、ロキシスロマイシン、アジスロマイシンも使用される。
- スピラマイシンやジョサマイシンは無効である。
- × 好中球性炎症性気道疾患として保険適応となる。
- 本邦の工藤らが 1980 年代に報告した。
- × マクロライド系抗菌薬には殺菌的役割よりも、緑膿菌のバイオフィルム形成阻害、増殖抑制などが期待される。
- 宿主側の好中球走化因子産生や好中球接着因子発現の抑制などの効果が期待される。
- 上皮細胞の塩化物イオンチャネルへの作用やムチン産生抑制効果があり、粘液の過剰分泌が抑制される。
- × 増悪期の起因菌を断定することは難しいが、緑膿菌も起因菌になりうる。
- × マクロライド系抗菌薬の少量長期療法の普及により 5 年生存率は劇的に改善し、90% 以上である。
- 両肺移植は 55 歳未満、片肺移植は 60 歳未満の薬物治療に抵抗性の症例が対象となる。